Dịch tễ học ung thư: Sự phân bố, nguy cơ, giám sát và phòng ngừa

TS. BS. Lê Vĩnh Giang

Bộ môn Dịch tễ học

Trường ĐHY Hà Nội

giangvinhle@hmu.edu.vn

Mục tiêu bài học

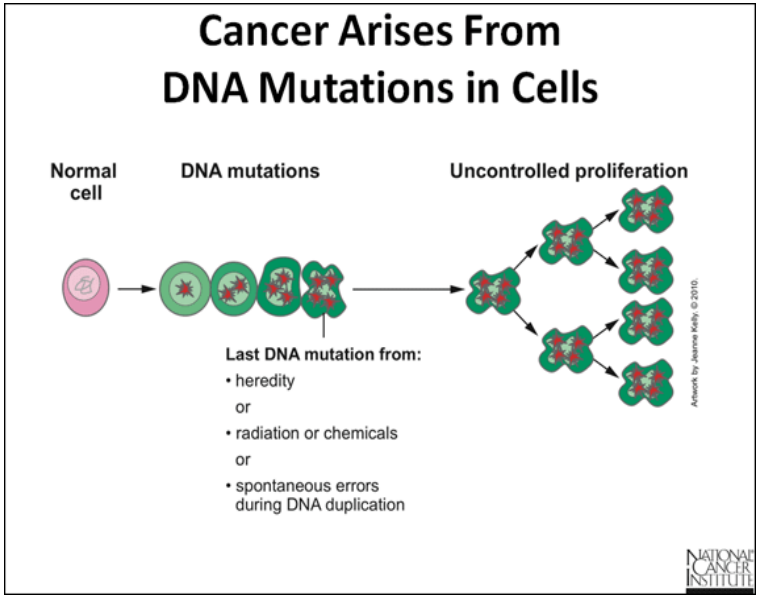
1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về ung thư
2. Trình bày được sự phân bố và các loại ung thư hay gặp ở Việt Nam
3. Trình bày được các tác nhân/yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư
4. Trình bày được định nghĩa, mục tiêu và ứng dụng của ghi nhận ung thư
5. Mô tả được các bước tiến hành ghi nhận ung thư
6. Trình bày được nguyên lý và chiến lược dự phòng bệnh ung thư
7. Trình bày được cách phòng chống tác hại của thuốc lá

Phần I

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA BỆNH UNG THƯ

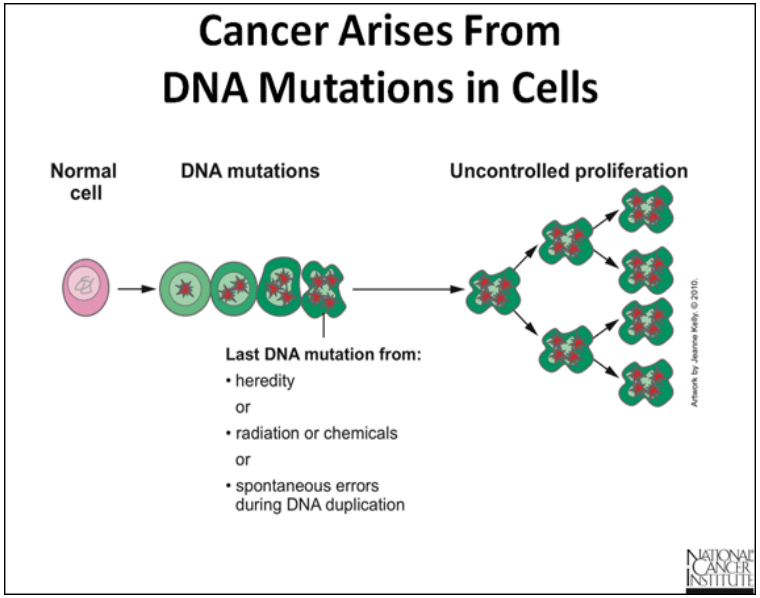
Ung thư là gì?

- Nhóm bệnh (>100 loại)
- Bệnh lý ác tính của TB
- 5-10 % các loại UT phát sinh do gen.
- 90-95%: lối sống, môi trường, dinh dưỡng



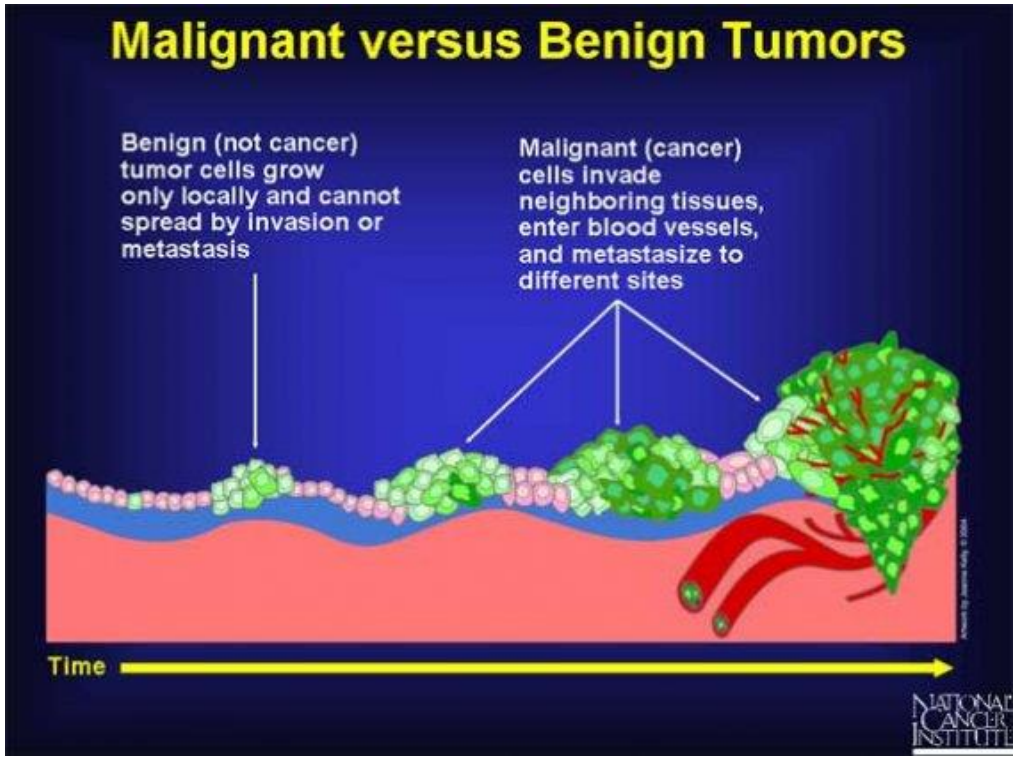
Ung thư là gì?

- Gen Ras: 40-70% u tuyến và ung thư biểu mô sớm
- Gen apc: 70% bệnh đa polyp đại trực tràng có tính gia đình
- Gen dcc: 50% u tuyến và trên 70% UTĐTT
- Gen P53: UTĐTT giai đoạn muộn



Ung thư là gì?

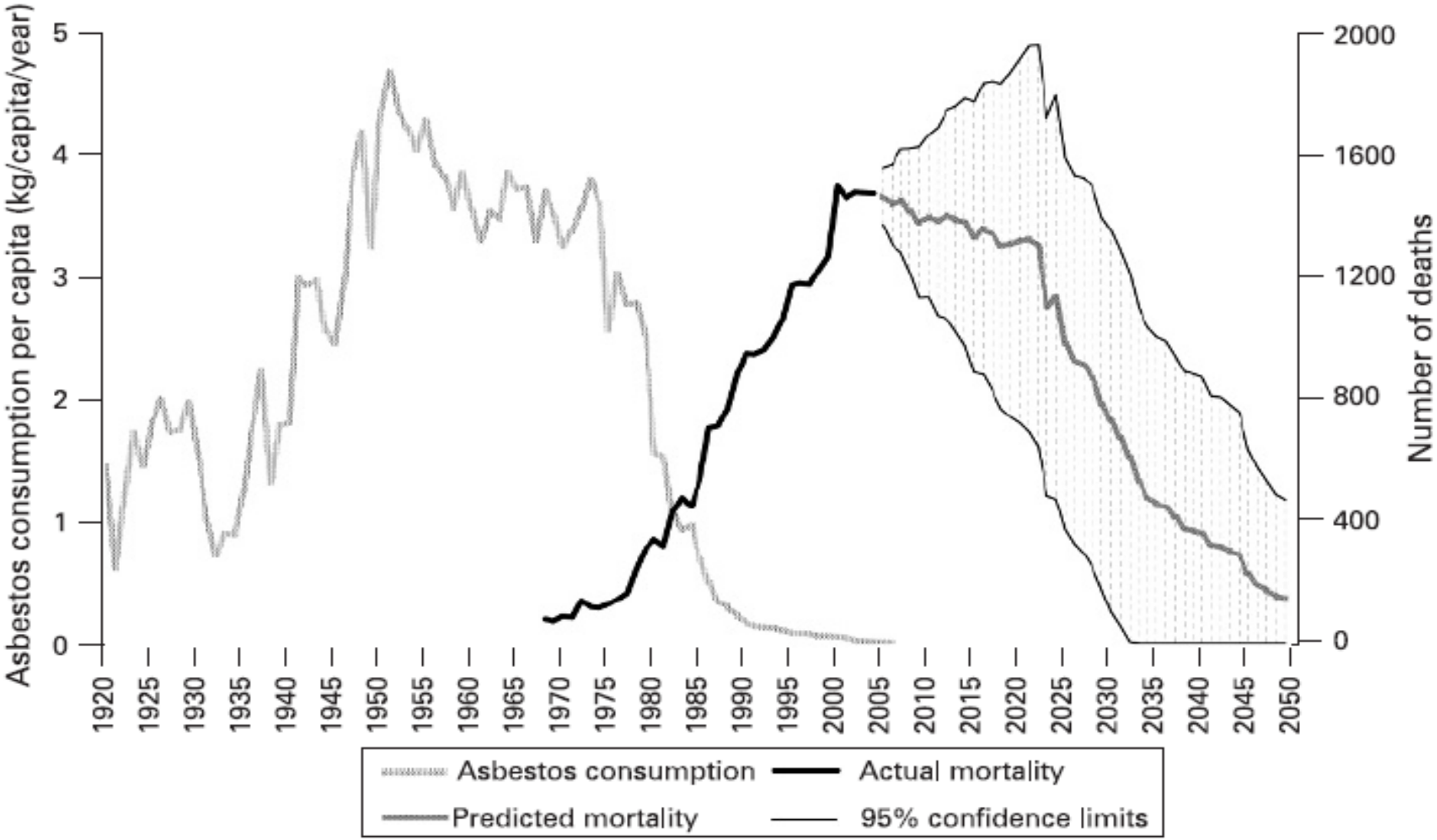
- Khối u lành tính
- Khối u ác tính



DTH bệnh ung thư là gì?

- Sự phân bố của bệnh ung thư xuất hiện trong các quần thể khác nhau
- Các yếu tố chi phối
- Các kết quả nghiên cứu này làm cơ sở cho công tác dự phòng bệnh ung thư
- So sánh các nhóm quần thể
- Đánh giá mỗi tương quan

Tiêu thụ amiăng (kg/người) và tử vong UT trung biểu mô ở Mỹ



Lịch sử nghiên cứu bệnh ung thư

- Ung thư có từ khi nào?
- Hippocrates (460-375 trước CN)
- Percival Pott (1775): UT bìu ở những CN tiếp xúc bồ hóng

An engraving from 1687 of Seyley and his boy. (Marcellus Lauron)

Lịch sử nghiên cứu bệnh ung thư

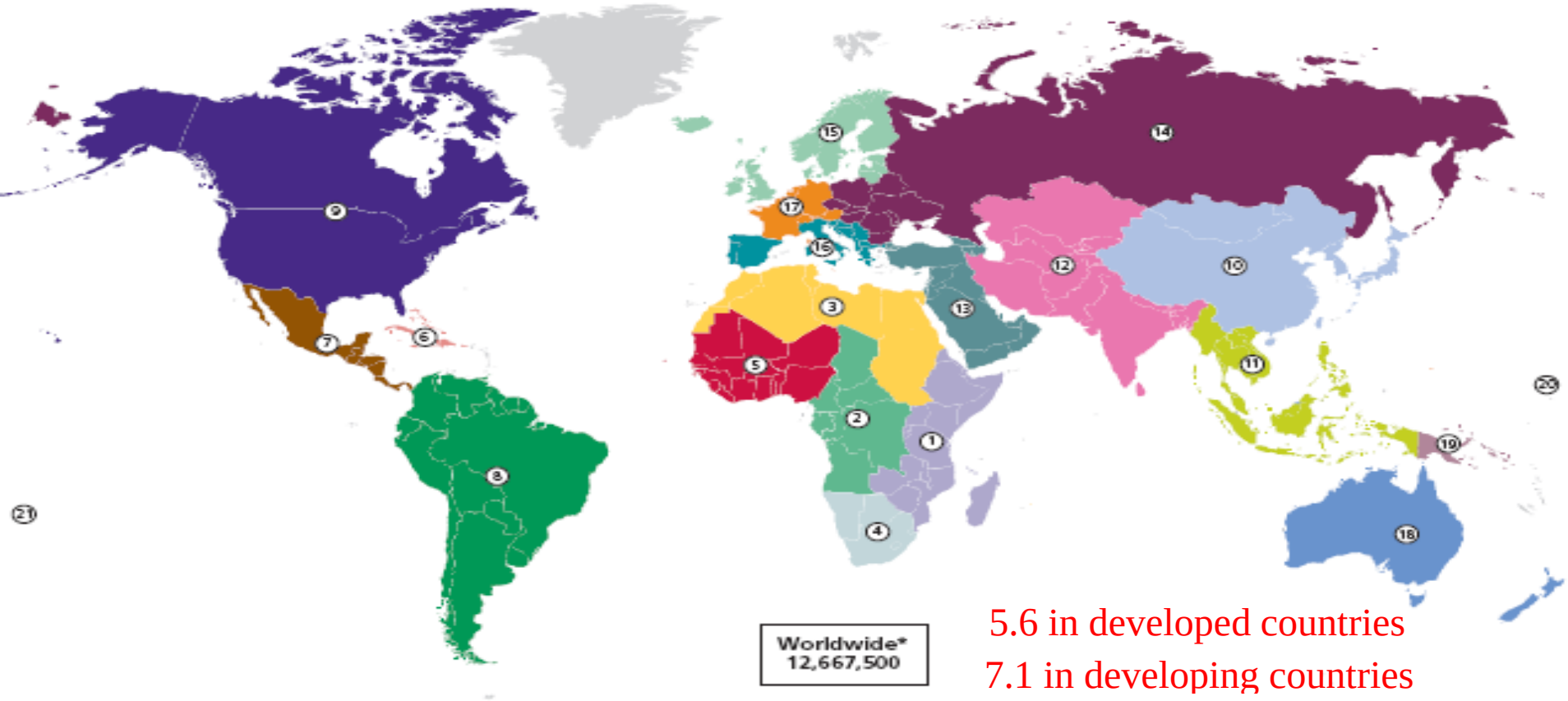
- R. Virchop (1863): người đầu tiên đưa ra giả thiết về mối liên quan giữa ung thư và các **khối viêm mạn tính**
- DV. Hansemann (1890): NC các mô bị UT và quan sát thấy **nhân TB bất thường**, coi đó là sự khởi đầu sự phát triển bệnh
- Watson và Cric (1962): đưa ra mô hình chuỗi xoắn DNA, mô phỏng các loại gen của TB
- R. Doll và Peto (1979): nhấn mạnh vai trò quan trọng của **hút thuốc lá, dinh dưỡng và nhiễm trùng**
- C. Milstein (1981) phát triển kỹ thuật sản **xuất kháng thể đơn dòng**: herceptin-UT vu
- SD. Thomas thành công ghép tủy xương trên người, ứng dụng điều trị tia xạ, hóa chất liều cao trong bệnh BC cấp

Gánh nặng bệnh tật do ung thư

- Số TH/tỷ lệ mới mắc
- Số TH/tỷ lệ hiện mắc
- Số TH/tỷ lệ đặc hiệu
- Số TH/tỷ lệ thô
- Tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi
- DALY, YPLL, YLD

Tình hình bệnh ung thư trên thế giới

Estimated Number of New Cancer Cases by World Area, 2008*



5.6 in developed countries

7.1 in developing countries

By 2030: 21.4 new cases and 13.2 deaths

1 Eastern Africa (221,100)
2 Middle Africa (66,900)
3 Northern Africa (164,400)
4 Southern Africa (79,200)
5 Western Africa (184,100)
6 Caribbean (79,300)
7 Central America (176,600)
8 South America (650,100)
9 Northern America (1,603,900)
10 Eastern Asia (3,720,700)
13 Western Asia (223,300)
14 Central and Eastern Europe (985,200)
15 Northern Europe (480,200)
18 Australia/New Zealand (127,000)
19 Melanesia (7,000)
20 Micronesia (700)
21 Polynesia (1,100)

*Region estimates do not sum to the worldwide estimate due to calculation method.
Source: GLOBOCAN 2008.

Table 1. Leading Causes of Death Worldwide and in Developing and Developed Countries, 2004 (thousands)

	Worldwide			Developing			Developed		
	Rank	Deaths	%	Rank	Deaths	%	Rank	Deaths	%
Heart diseases	1	8,923	15.1	1	7,342	14.5	2	1,563	19.3
Malignant neoplasms	2	7,424	12.6	2	5,255	10.4	1	2,154	26.6
Cerebrovascular diseases	3	5,712	9.7	3	4,949	9.8	3	757	9.4
Lower respiratory infections	4	4,177	7.1	4	3,910	7.7	4	305	3.8
Perinatal conditions*	5	3,180	5.4	5	3,141	6.2		35	0.4
Chronic obstructive pulmonary disease	6	3,025	5.1	6	2,737	5.4	5	285	3.5
Diarrhoeal diseases	7	2,163	3.7	7	2,148	4.2		14	0.2
HIV/AIDS	8	2,040	3.5	8	2,018	4.0		20	0.2
Tuberculosis	9	1,464	2.5	9	1,448	2.9		15	0.2
Road traffic accidents	10	1,275	2.2	10	1,158	2.3		114	1.4
Diabetes mellitus	11	1,141	1.9		914	1.8	7	221	2.7
Malaria	12	889	1.5		888	1.8		0	0.0
Suicide	13	844	1.4		707	1.4	9	118	1.5
Cirrohsis of the liver	14	772	1.3		655	1.3	10	116	1.4
Nephritis and nephrosis	15	739	1.3		611	1.2	8	126	1.6
All causes		58,772	100.0		50,582	100.0		8,095	100.0

The number zero in a cell indicates a non-zero estimate of less than 500.

* Includes "causes arising in the perinatal period" as defined in the International Classification of Diseases, principally low birthweight, prematurity, birth asphyxia, and birth trauma, and does not include all causes of deaths occurring in the perinatal period.

Source: World Health Organization, The global burden of disease: 2004 update.

Table 3. The Two Most Common Types of New Cancer Cases and Deaths by World Area, 2008

	Cancer Cases							
	Males				Females			
	First		Second		First		Second	
Eastern Africa	Kaposi sarcoma	15.8%	Esophagus	10.4%	Cervix uteri	26.2%	Breast	14.9%
Middle Africa	Liver	23.6%	Prostate	14.1%	Breast	22.1%	Cervix uteri	22.0%
Northern Africa	Lung & bronchus	12.7%	Bladder	12.5%	Breast	33.8%	Cervix uteri	6.4%
Southern Africa	Prostate	19.2%	Lung & bronchus	11.5%	Breast	23.4%	Cervix uteri	16.9%
Western Africa	Liver	19.2%	Prostate	18.3%	Breast	26.4%	Cervix uteri	25.9%
Caribbean	Prostate	37.3%	Lung & bronchus	13.0%	Breast	24.6%	Cervix uteri	13.0%
Central America	Prostate	24.4%	Stomach	9.1%	Breast	18.9%	Cervix uteri	16.9%
South America	Prostate	26.4%	Lung & bronchus	10.6%	Breast	26.6%	Cervix uteri	14.4%
North America	Prostate	25.7%	Lung & bronchus	15.1%	Breast	26.6%	Lung & bronchus	14.3%
Eastern Asia	Lung & bronchus	20.4%	Stomach	19.1%	Breast	15.2%	Lung & bronchus	13.2%
South-Eastern Asia	Lung & bronchus	19.8%	Liver	15.1%	Breast	22.4%	Cervix uteri	11.4%
South-Central Asia	Lung & bronchus	12.3%	Oral cavity	9.4%	Cervix uteri	22.5%	Breast	22.4%
Western Asia	Lung & bronchus	19.0%	Colon & rectum	8.4%	Breast	27.2%	Colon & rectum	8.2%
Central and Eastern Europe	Lung & bronchus	22.2%	Colon & rectum	13.0%	Breast	23.4%	Colon & rectum	13.3%
Northern Europe	Prostate	27.3%	Lung & bronchus	14.3%	Breast	30.0%	Colon & rectum	12.1%
Southern Europe	Prostate	20.0%	Lung & bronchus	17.0%	Breast	29.0%	Colon & rectum	14.2%
Western Europe	Prostate	29.8%	Lung & bronchus	13.4%	Breast	32.1%	Colon & rectum	13.8%
Australia/New Zealand	Prostate	29.8%	Colon & rectum	13.4%	Breast	28.4%	Colon & rectum	14.0%
Melanesia	Oral cavity	16.1%	Liver	10.3%	Cervix uteri	19.5%	Breast	17.1%
Micronesia	Lung & bronchus	29.9%	Prostate	15.9%	Breast	35.7%	Colon & rectum	11.6%
Polynesia	Prostate & Lung	20.1%	Colon & rectum	6.4%	Breast	29.6%	Thyroid	12.2%

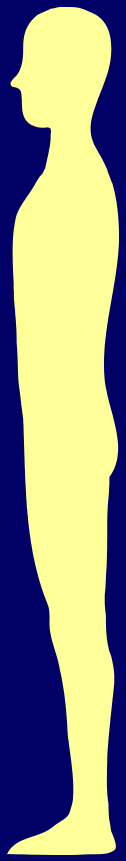
Table 3. The Two Most Common Types of New Cancer Cases and Deaths by World Area, 2008

	Cancer Deaths							
	Males				Females			
	First		Second		First		Second	
Eastern Africa	Kaposi sarcoma	16.0%	Esophagus	11.8%	Cervix uteri	24.5%	Breast	11.3%
Middle Africa	Liver	26.6%	Prostate	13.3%	Cervix uteri	20.7%	Breast	16.9%
Northern Africa	Lung & bronchus	14.7%	Bladder	10.1%	Breast	26.3%	Colon & rectum	5.6%
Southern Africa	Lung & bronchus	14.8%	Esophagus	13.1%	Breast	17.5%	Cervix uteri	13.6%
Western Africa	Liver	22.2%	Prostate	17.5%	Cervix uteri	24.9%	Breast	21.0%
Caribbean	Prostate	24.9%	Lung & bronchus	19.6%	Breast	15.8%	Lung & bronchus	12.7%
Central America	Prostate	15.5%	Lung & bronchus	13.8%	Cervix uteri	13.7%	Breast	11.6%
South America	Lung & bronchus	15.6%	Prostate	14.6%	Breast	14.6%	Cervix uteri	11.8%
North America	Lung & bronchus	30.4%	Prostate	9.8%	Lung & bronchus	25.9%	Breast	14.9%
Eastern Asia	Lung & bronchus	24.7%	Liver	20.3%	Lung & bronchus	19.1%	Stomach	15.5%
South-Eastern Asia	Lung & bronchus	22.4%	Liver	18.2%	Breast	15.2%	Lung & bronchus	11.5%
South-Central Asia	Lung & bronchus	14.6%	Oral cavity	8.1%	Cervix uteri	19.8%	Breast	17.1%
Western Asia	Lung & bronchus	23.7%	Stomach	9.3%	Breast	19.0%	Colon & rectum	8.1%
Central and Eastern Europe	Lung & bronchus	28.3%	Colon & rectum	11.5%	Breast	16.8%	Colon & rectum	14.6%
Northern Europe	Lung & bronchus	23.6%	Prostate	14.0%	Lung & bronchus	18.6%	Breast	15.8%
Southern Europe	Lung & bronchus	27.1%	Colon & rectum	11.6%	Breast	16.5%	Colon & rectum	13.1%
Western Europe	Lung & bronchus	25.6%	Colon & rectum	11.5%	Breast	18.2%	Colon & rectum	13.3%
Australia/New Zealand	Lung & bronchus	20.1%	Prostate	14.6%	Lung & bronchus	16.4%	Breast	15.7%
Melanesia	Liver	12.7%	Oral cavity	9.1%	Cervix uteri	18.7%	Breast	13.6%
Micronesia	Lung & bronchus	30.2%	Colon & rectum	11.7%	Breast & lung	17.8%	Colon & rectum	11.2%
Polynesia	Lung & bronchus	30.0%	Prostate	10.0%	Breast	16.7%	Lung & bronchus	15.4%

Source: GLOBOCAN 2008.

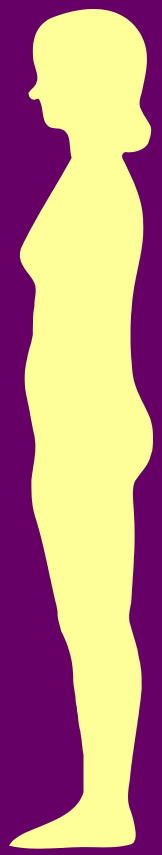
10 COMMON CANCER IN VIETNAM 2010

	Site	Cases	ASR	Estimated in 2020
1	Lung	14,652	35.1	22,938
2	Stomach	10,384	24.5	11,502
3	Liver	9,372	23.6	11,039
4	Colorectum	7,568	19.0	13,269
5	Esophagus	3,872	9.9	10,920
6	Nasopharyn	2,992	7.5	3,468
7	lymphoma	2,552	6.3	3,158
8	Leukaemia	2,244	5.5	3,109
9	Prostate	1,716	4.7	2,989
10	Ballder	1,276	3.3	1,479



Cancer Registries, 2010

10 COMMON CANCER IN VIETNAM 2010



	Site	Cases	ASR	Estimated in 2020
1	Breast	12,533	29.9	22,612
2	Colorectum	6,110	14.7	11,124
3	Lung	5,709	13.9	11,656
4	Cervic	5,664	13.6	6,604
5	Stomach	4,728	12.2	5,512
6	Thyroid	3,211	8.4	6,744
7	Liver	2,319	5.6	3,004
8	Ovary	2,185	6.3	5,548
9	Lymphoma	1,427	3.7	1,764
10	Leukaemia	1,338	3.3	1,560

Cancer Registries, 2010

Phần II

TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH UNG THƯ

Ung thư không phải do một tác nhân gây ra

- Nhiều loại UT không biết nguyên nhân
- Một tác nhân sinh UT có thể gây ra 1 số loại UT, ngược lại 1 loại UT có thể do 1 số tác nhân khác nhau gây ra.
- Được nghiên cứu rộng rãi và trải qua một thời gian dài

Tác nhân bên trong

1. Yếu tố di truyền

- Có sự liên quan chặt chẽ giữa biến đổi vật liệu di truyền và sự xuất hiện ung thư
- UT liên bào võng mạc mắt và UT tuyến giáp thể lõi
- Ung thư vú
- Đa polyp đại tràng và UT đại tràng

Tác nhân bên trong

2. Yếu tố nội tiết

- Chưa có bằng chứng thuyết phục khẳng định RL nội tiết gây ra UT
- Có sự liên quan giữa một số UT và RL nội tiết

- Giảm nội tiết tố sd nam, tang nguy co UTTLT
- K vu phat trien manh o nhung nguoi co thai va cho con bu

Tác nhân bên ngoài

1. Vật lý

- Bức xạ ion hóa trong TN hoặc do con người tạo ra
- Gồm tia gamma, X, hạt proton, electron, α, neutron
- Tác động lên vật chất với mật độ thưa thớt: gamma, X, electron
- Dày đặc: α, neutron
- Hậu quả: diệt TB, sai lạc NST, đột biến, ung thư
- Các yếu tố làm thay đổi nguy cơ: tuổi, liều, cq chiếu xạ, gen di truyền nhạy cảm đối với 1 số UT đặc biệt

Tác nhân bên ngoài

BẢNG 1. ***Những nghiên cứu về quần thể phơi nhiễm bức xạ***

BOM NGUYÊN TỬ

Những người Nhật Bản sống sót

PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP

Bác sỹ X-quang
Công nhân dưới lòng đất
Thợ sơn mặt đồng hồ có chứa radium
Công nhân hạt nhân
Chuyên gia công nghệ bức xạ

PHƠI NHIỄM Y TẾ

Các bệnh nhân viêm cột sống dính khớp
Phì đại tuyến ức
Bệnh tuyến vú lành tính
Bệnh phụ khoa lành tính
Nghiệm huỳnh quang trong điều trị lao
Ung thư vùng cổ
Bệnh Hodgkin
Ung thư vú
Ung thư trẻ em

Tác nhân bên ngoài

- Ánh sáng tử ngoại-tia cực tím (UV)
- UV từ mặt trời là tác nhân chính gây UT da
- Nông dân, người da trắng, tiền sử cháy nắng, tuổi có nguy cơ cao với ung thư da

Tác nhân bên ngoài

- "Asbestos" is a generic name given to a fibrous variety of six naturally occurring silicate minerals (USGS, 2006)
  - **Chrysotile (white)**
  - **Amosite (brown)**
  - **Crocidolite (blue)**
  - **Tremolite**
  - **Anthophyllite**
  - **Actinolite**
- A commercial-industrial term
- Asbestos has been used in numerous commercial applications including fire proofing materials, ceiling tiles, floor tiles, insulation, brake linings, and became an important factor for economic development

Tác nhân bên ngoài

- Asbestos is one of the most important occupational carcinogens, and the burden of asbestos-related diseases is rising
- 107,000 asbestos-related deaths (WHO 2010)
- 125 million people are occupationally exposed to asbestos
- The best way to eliminate asbestos-related diseases is to stop asbestos use

Tác nhân bên ngoài

2. Hóa học

- Các chất gây UT gây độc cho gen, tạo nên các liên kết đồng hóa trị với các đại phân tử, DNA đích trong nhân và trong ty thể của tế bào
- Sự tương tác đó tạo nên các biến đổi bất thường trong vật chất di truyền, làm thay đổi chức năng tổng hợp của protein, và hoạt động của TB vật chủ

Bảng 2. Các hoá chất có thể sinh ung th đã đợc biết đến hoặc cha rõ ở ngời

Cơ quan	Các tác nhân	Nhóm nghề nghiệp	Loại ung th
Phổi	Khói thuốc lá, arsenic, asbestos, crystalline silicca, benzo [a] pyrene, beryllium, bis (chloro) methyl ether, 1,3-butadiene, hợp chất chromium VI, nhựa đờng, hắc ín, các hợp chất nickel [Ni(CO4)], bồ hóng, hơi mù tạc	Sản xuất nhôm, tiếp xúc khí đốt của than đá, sản xuất các dẫn suất của than đá, khai thác hematite, thợ sơn, công nhân sơn xuất mù tạc	Ung th biểu mô tế bào vẩy nhỏ (20-25%), tế bào vẩy lớn(10%), và ung th biểu mô tuyến (25-30%)
Màng phổi	Asbestos, erionite	Công nhân tiếp xúc với asbestos	Ung th trung biểu mô
Khoang miệng	Khói thuốc lá, đồ uống có chứa cồn, hợp chất chứa nickel	Sản xuất dày da, chế biến gỗ, rợu isopropyl	Ung th biểu mô tế bào vẩy
T.Quản	Khói thuốc lá, đồ uống có chứa cồn		UT biểu mô tế bào vẩy
Dạ dày	Thực phẩm ngâm, muối mặn, hun khói	Công nghiệp cao su	Ung th biểu mô tuyến
đại tràng	Heterocyclic amines, asbestos	Sản xuất pattern	Ung th biểu mô tuyến
Gan	Aflatoxin, vinyl chloride, khói thuốc lá, đồ uống có chứa cồn, thorium dioxide		Ung th tế bào gan, sarcôm mạch máu
Thận	Khói thuốc lá, phenacetin		Ung th tế bào thận
Bàng quang	Khói thuốc lá, 4-aminobiphenyl, benzidine, 2-naphthylamine, phenacetin	SX tiếp xúc với thuốc nhuộm, sơn, cao su, hắc ín, khí gas	Ung th tế bào tái phát
Tiền liệt	Cadmium		Ung th biểu mô tuyến
Da	Arsenic, benzo[a] pyrene, nhựa đờng, hấc ín, dầu khoáng, bồ hóng, cyclosporin A, PUVA	Sản xuất, tiếp xúc với các dẫn suất, khí đốt than đá	Ung th biểu mô tế bào vẩy
Tuỷ xơng	Benzene, khói thuốc lá, ethylene oxide, các tác nhân chống ung th, cyclosporin A	Công nghiệp cao su	Bạch cầu, tế bào lympho

Tác nhân bên ngoài

2. Sinh học

- Virus chứa RNA
- Virus chứa DNA
- Vi khuẩn và ký sinh trùng có liên quan đến ung thư

➢ Vi khuẩn Helicobacter Pylori và UT dạ dày

➢ Sán Schistosoma và UT bàng quang, niệu quản

BẢNG 3. Virus ở người và đặc tính gây ung thư

Họ virus	Loại	Ung thư ở người	Yếu tố nguy cơ
Flaviviruses	HCV	UT biểu mô gan	-
Hepadanaviruses	HBV	UT biểu mô gan	Aflatoxin, rượu, thuốc lá
Herpesviruses	EBV HHV-8	Burkitt's lymphoma Immunoblastic lymphoma Vòm họng Hodgkin Leiomyosarcoma Ung thư dạ dày Kaposi Sarcoma Body cavity- lymphoma Castleman's diseases	Sốt rét Suy giảm miễn dịch Nitrosamine, HLA - - - Nhiễm HIV Nhiễm HIV Nhiễm HIV
Papillomaviruses	HPV-16,18,33,39	UT hậu môn, sinh dục 1 số UT đường hh trên	Hút thuốc? các yếu tố khác
Polyomaviruses	HPV-5,8,17 SV40,JC, BK	Ung thư da ? U não ? Insulinoma ? Mesothelioma	EV, ánh sáng, ức chế miễn dịch - -
Retroviruses	HTLV-1 HTLV-II	ATL Hairy cell leukemia	Không chắc chắn Không biết

Phần III

GHI NHẬN UNG THƯ

Giám sát DTH?

Giám sát
- Thu thập SL
- Phân tích SL
- Phiên giải KQ
- Phổ biến KQ

Hoạt động YTCC
- Xác định vấn đề SK u tiên
- Lập kế hoach, triển khai các hoạt động

Ghi nhận ung thư

- Là một hình thức giám sát đặc biệt ứng dụng trong chuyên ngành ung thư để *ghi nhận các ca bệnh* và *thông tin có liên quan*

- Ghi nhận ung thư tại bệnh viện: chẩn đoán, điều trị và chăm sóc

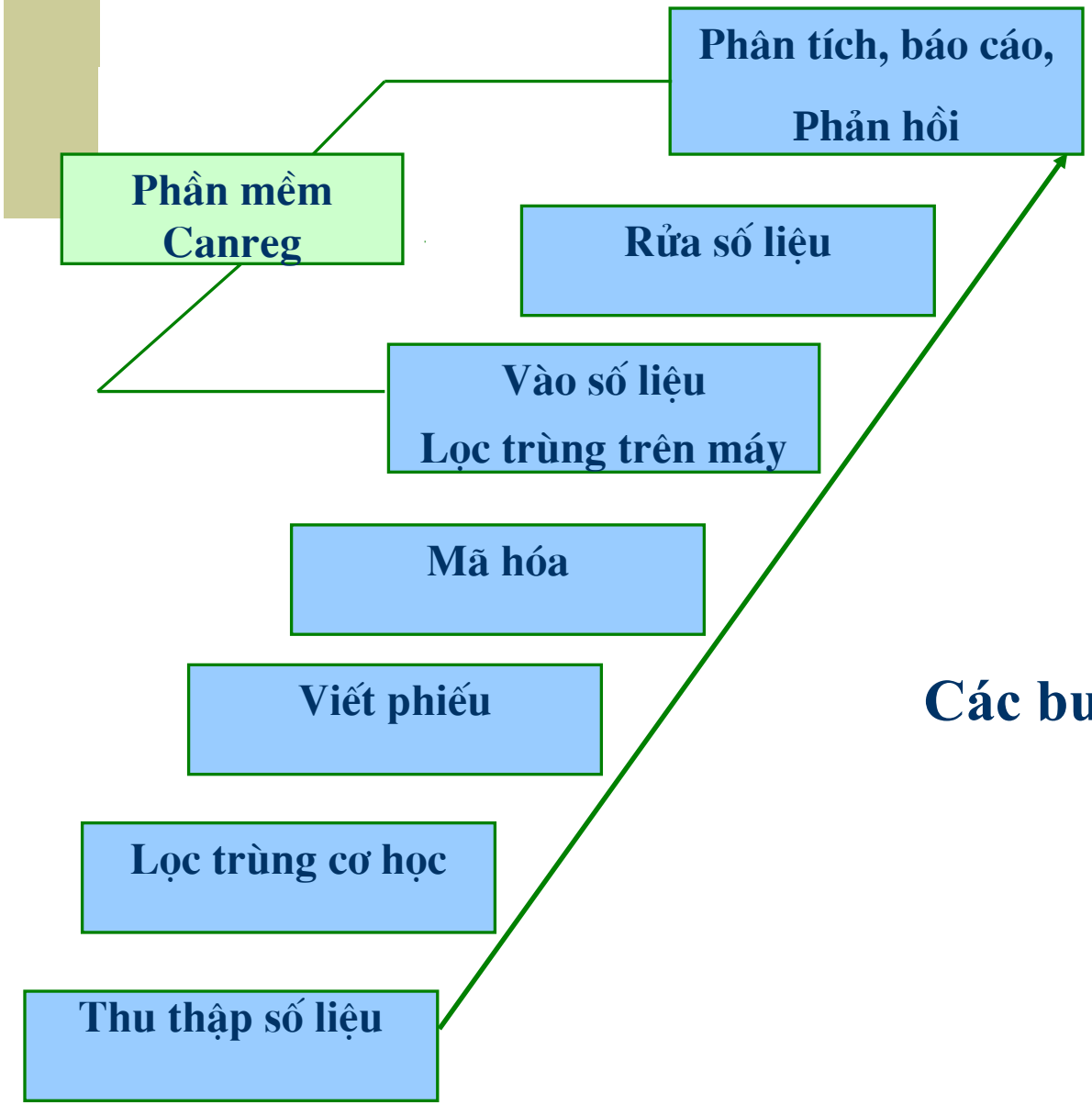
- Ghi nhận ung thư trong quần thể: phòng chống, sàng lọc

Mục đích của ghi nhận ung thư

- Phát hiện những biến đổi bất thường
- Hỗ trợ cho việc lập kế hoạch
- Đánh giá gánh nặng bệnh tật

Điều kiện cần thiết để thiết lập một trung tâm ghi nhận ung thư

- Hệ thống y tế phải đủ tốt
- Sổ sách, bệnh án phải đầy đủ thông tin
- Quần thể dân cư phải đủ lớn
- Nhân lực
- Phương tiện
- Tài chính



Các bước tiến hành

Thông tin ghi nhận

- Họ tên
- Giới tính
- Tuổi
- Nơi ở
- Bệnh viện: nơi thu nhận BN
- Ngày chẩn đoán
- Vị trí U nguyên phát
- Phân loại GPB hoặc TB

Khó khăn

- Ghi chép vội vàng do tình trạng quá tải
- Thiều thông tin: tuổi, giới...
- Địa chỉ BN ko đầy đủ, khó khăn trong việc tra cứu
- Khai địa chỉ khác nhau, ko xác định được địa bàn
- Quần thể dân cư không ổn định
- Kinh phí hạn chế

Phần IV

DỰ PHÒNG UNG THƯ

Nguyên lý chung

- Dự phòng bước 1
- Dự phòng bước 2
- Dự phòng bước 3

Các biện pháp cụ thể

1. Chống hút thuốc lá

- Tăng cường cấm hút thuốc lá nơi công cộng
- Hạn chế/loại trừ quảng cáo, sản xuất thuốc lá
- Tăng thuế đối với sx/nhập khẩu
- Tuyên truyền hậu quả của thuốc lá: con số, hình ảnh
- Tư vấn bỏ thuốc lá

Các biện pháp cụ thể

2. Dinh dưỡng hợp lý

- Liên quan tới 30-40% ung thư ở nam, 60% ung thư ở nữ
- Uống nhiều rượu + hút thuốc
- Thực phẩm có nhiều chất hun khói, chất bảo quản
- Ít hàm lượng rau củ quả

Liên quan giữa chế độ dinh dỡng và một số loại ung th

Vị trí ung th	Nhiều chất béo	Quá cân	Nhiều chất xơ	Nhiều rau quả	Uống nhiều rọu	hun khói, da muối
Phổi				-		
Vú	+	++ **		-		
§ại tràng	++		-	-		
Tiền liệt tuyến	++					
Bàng quang				-		
Trực tràng	+			-	+	
Nội mạc tử cung	+	+++				
Khoang miệng				-	+ *	
Dạ dày				-		++
Thực quản				-	++*	+

Các biện pháp cụ thể

2. Dinh dưỡng hợp lý

- Chủ động thực hiện đầy đủ, thường xuyên các lời khuyên trong ăn uống
- Đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, phối hợp nhiều loại thực phẩm
- Tránh ăn quá nhiều chất béo
- Tránh ăn/uống thức ăn quá nóng
- Tránh ăn quá mặn
- Tránh ăn thức ăn bị mốc
- Ăn nhiều rau

Các biện pháp cụ thể

3. Chống nghiện rượu

- Khoang miệng, họng, hầu, thực quản, đại tràng
- Chống nghiện ngập lạm dụng

Các biện pháp cụ thể

4. Sinh đẻ có kế hoạch

- Không đẻ trước 20 tuổi, không đẻ nhiều con, QHTD an toàn : giảm nguy cơ mắc UT CTC
- Không đẻ muộn trên 40 tuổi, tránh dùng thuốc tránh thai, cho con bú sữa mẹ: giảm nguy cơ mắc UT vú

BKLN

4 bệnh, 4 yếu tố nguy cơ chung có thể thay đổi được

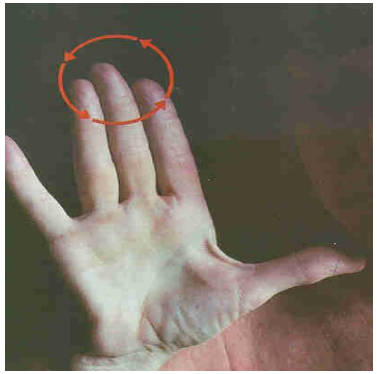
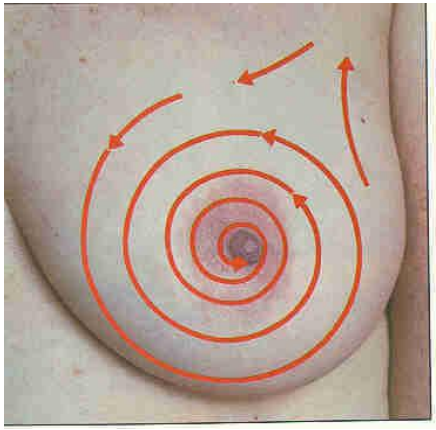
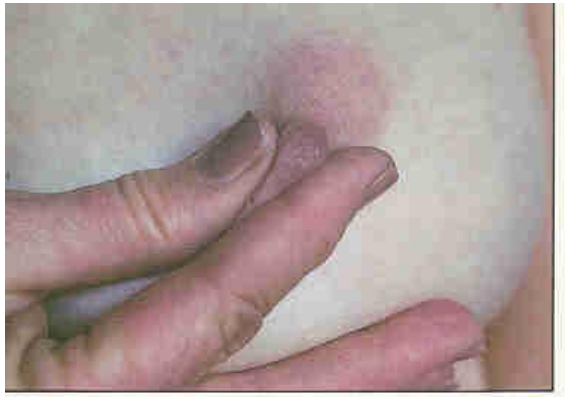
	Hút thuốc lá	Dinh dưỡng không hợp lý	Không hoạt động thể lực	Lạm dụng rượu bia
Bệnh tim mạch	✓	✓	✓	✓
Đái tháo đường	✓	✓	✓	✓
Ung thư	✓	✓	✓	✓
Bệnh phổi mãn tính	✓			

Phát hiện sớm một số ung thư thường gặp

1. Ung thư vú

- Tự khám vú: PN >= 20 tuổi
- X-quang vú: PN >= 40 tuổi/năm/lần
- Khám vú tại cơ sở chuyên khoa: PN >= 40 tuổi/năm/lần

Phát hiện sớm một số ung thư thường gặp

Phát hiện sớm một số ung thư thường gặp

2. Ung thư cổ tử cung

- Pap test: phát hiện độ thoai hóa TB
- Kết hợp với khám phụ khoa hàng năm ở PN >18 tuổi có QHTD
- Soi CTC kết hợp nhuộm bằng acid acetic (VIA) or lugol (VILI), sinh thiết vùng nghi ngờ, phát hiện các tổn thương dạng tiền UT
- XN HPV

Phát hiện sớm một số ung thư thường gặp

3. Ung thư đại trực tràng

- Thay đổi phân
- Chảy máu trực tràng
- Tăng áp lực trong trực tràng
- Đau bụng bất thường
- Polyp
- Khám bằng tay 1 năm/lần ở tuổi >40
- Nội soi
- Fobt test

Phát hiện sớm một số ung thư thường gặp

4. Ung thư da

- Vùng da hở
- Vết loét dai dẳng ở da
- Những thay đổi tại vùng da bị sừng hóa
- Nổi cục, vết đốm, màu sắc
- Nốt ruồi phát triển to nhanh
- Thay đổi bề mặt của nốt ruồi: gồ ghề, loét

Phát hiện sớm một số ung thư thường gặp

5. Ung thư khoang miệng

- Màu sắc niêm mạc bất thường, loét
- Vết thương khó liền
- Chảy máu
- Nốt sùi
- Há miệng bị hạn chế

Phát hiện sớm một số ung thư thường gặp

6. Ung thư tiền liệt tuyến

- Tần suất đi tiểu thay đổi
- Dòng nước tiểu yếu
- Rỉ nước tiểu sau khi đã tiểu tiện
- Thăm khám trực tràng bằng tay + XN PSA ở nam >=50 tuổi

7. Gan

SA

AFB